42. DÉVELOPPEMENT DES EXTRÉMITÉS

DURÉE : 10:30 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo met en lumière le lien fascinant entre le développement des membres et les structures internes, notamment le cerveau et le tube digestif. Vous apprendrez comment les blessures de l'enfance peuvent influencer des douleurs actuelles et comment des approches en médecine chinoise et en ostéopathie peuvent être intégrées pour traiter les tendinites et autres douleurs articulaires. Les concepts clés abordés incluent la dynamique du péritone, l'importance des vaisseaux sanguins dans la formation des membres, et l'interaction entre os et muscles au cours du développement. En comprenant ces relations complexes, vous serez mieux équipé pour traiter efficacement les lésions des membres et améliorer la santé globale de vos patients.

DÉVELOPPEMENT DES EXTRÉMITÉS

Le développement des membres se produit en parallèle avec les structures internes, notamment le **cerveau** et le **tube digestif**. Après la rotation, les membres inférieurs et supérieurs se forment simultanément.

Une **tendinite** peut être le reflet d'un déficit de rotation du **péritone**. Par exemple, une personne présentant une douleur au niveau du poignet, souvent diagnostiquée comme un **tennis elbow**, peut ne pas avoir pratiqué ce sport. Il est crucial d'explorer les aspects **pulmonaires** ou **viscéraux** pour comprendre l'origine du problème. En analysant l'organisation du système, on peut traiter le viscéral pour libérer les membres.

En médecine chinoise, des points spécifiques de la périphérie sont stimulés pour traiter des problèmes internes. L'empreinte du péritone peut se réactiver pour réutiliser des fonctions antérieures. Les blessures majeures de la vie se produisent souvent avant l'âge de 5 ans, et certaines peuvent même remonter à la phase embryonnaire. Ce qui se passe dans le corps peut se refléter dans les membres.

Le **cellulome** et le **tube neural** jouent un rôle essentiel dans le développement. Un angle spécifique crée un champ d'aspiration, influençant la croissance. Un champ métabolique avec des zones de restriction et d'hypercroissance entraîne des mouvements de croissance différentielle, influencés par le système vasculaire.

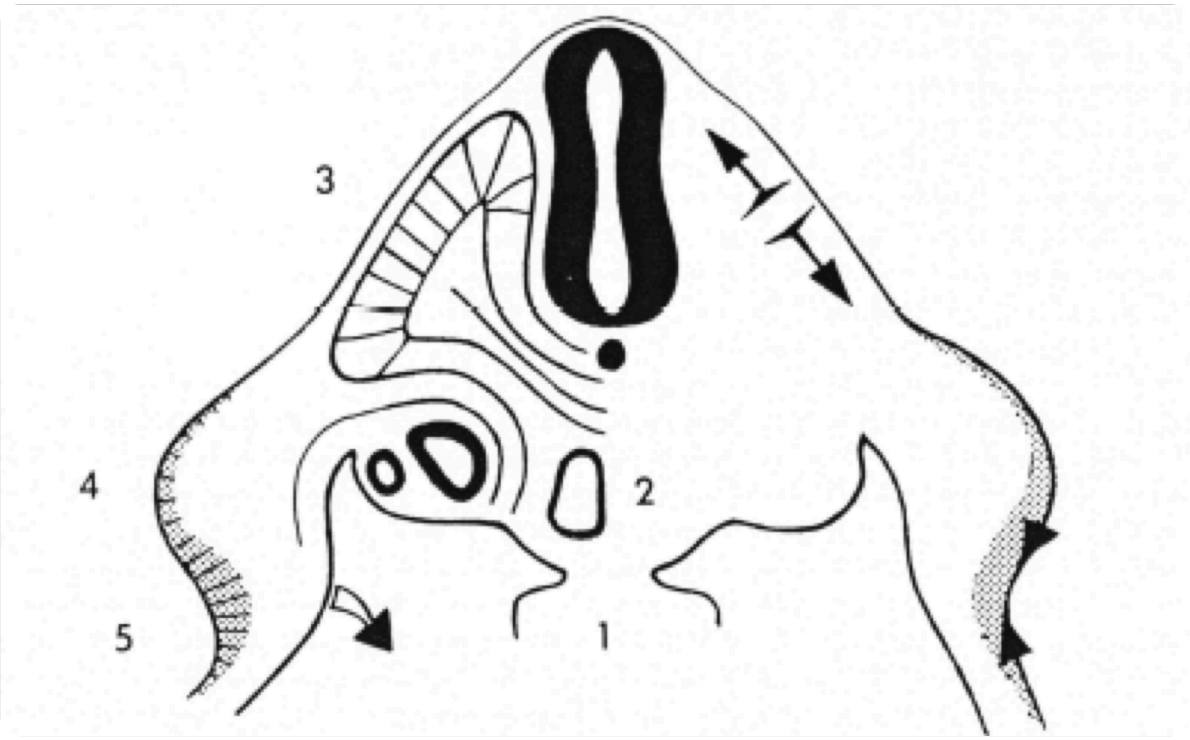


FIG. — Concept de champs d'aspiration et de restriction, se plaçant logiquement après l'explication de ces mécanismes dans les cellules et le tube neural

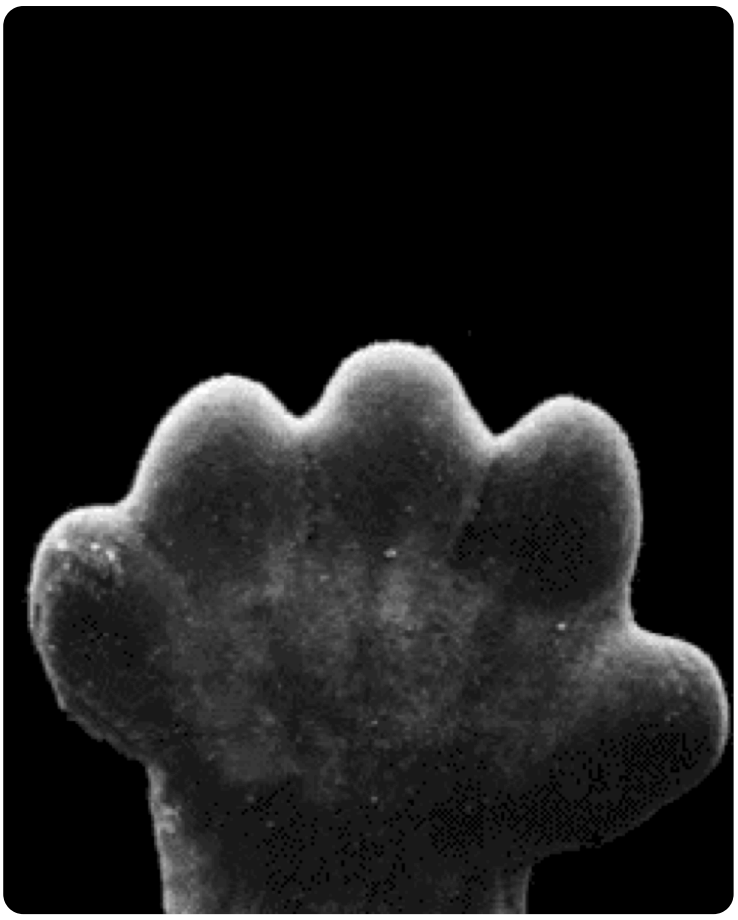


FIG. — Bourgeon de membre

Un métabolisme actif génère un flux puissant dans le tissu **mésenchymateux**, favorisant la croissance du tissu **ectodermique**.

La main apparaît en premier dans le développement, suivie par l'allongement du système.

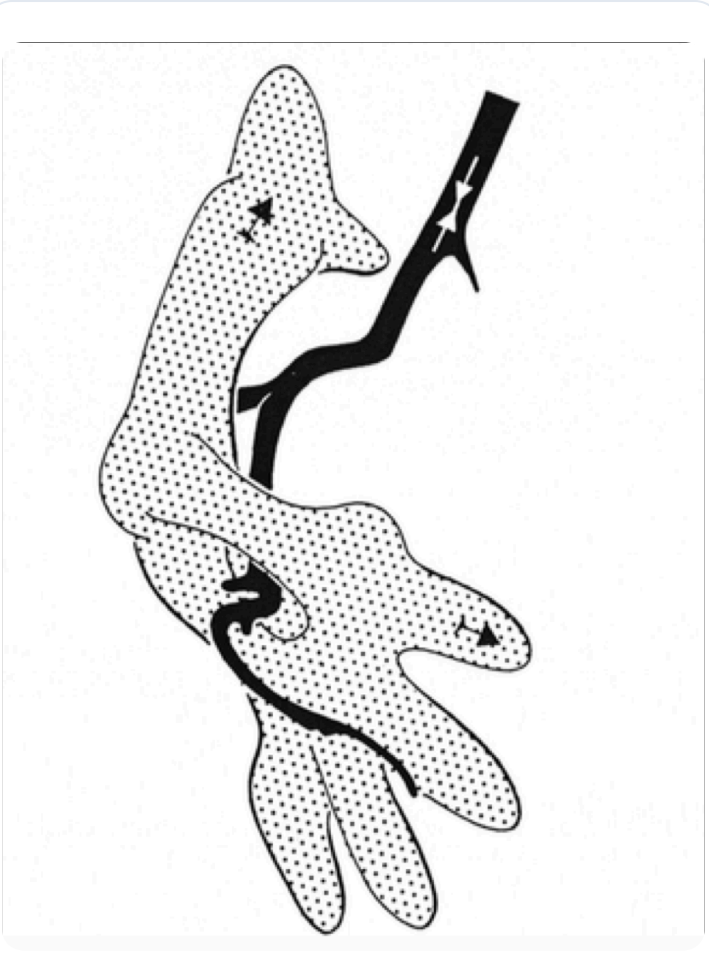


FIG. — Développement des membres

La flexion de l'embryon est liée à la vitesse de croissance par rapport à l'aorte.

Les articulations suivent un protocole similaire, où la présence de vaisseaux sanguins influence la densité et la forme des structures. Le mouvement de rotation externe est suivi d'une contre-rotation interne, orchestrée par le champ vasculaire.

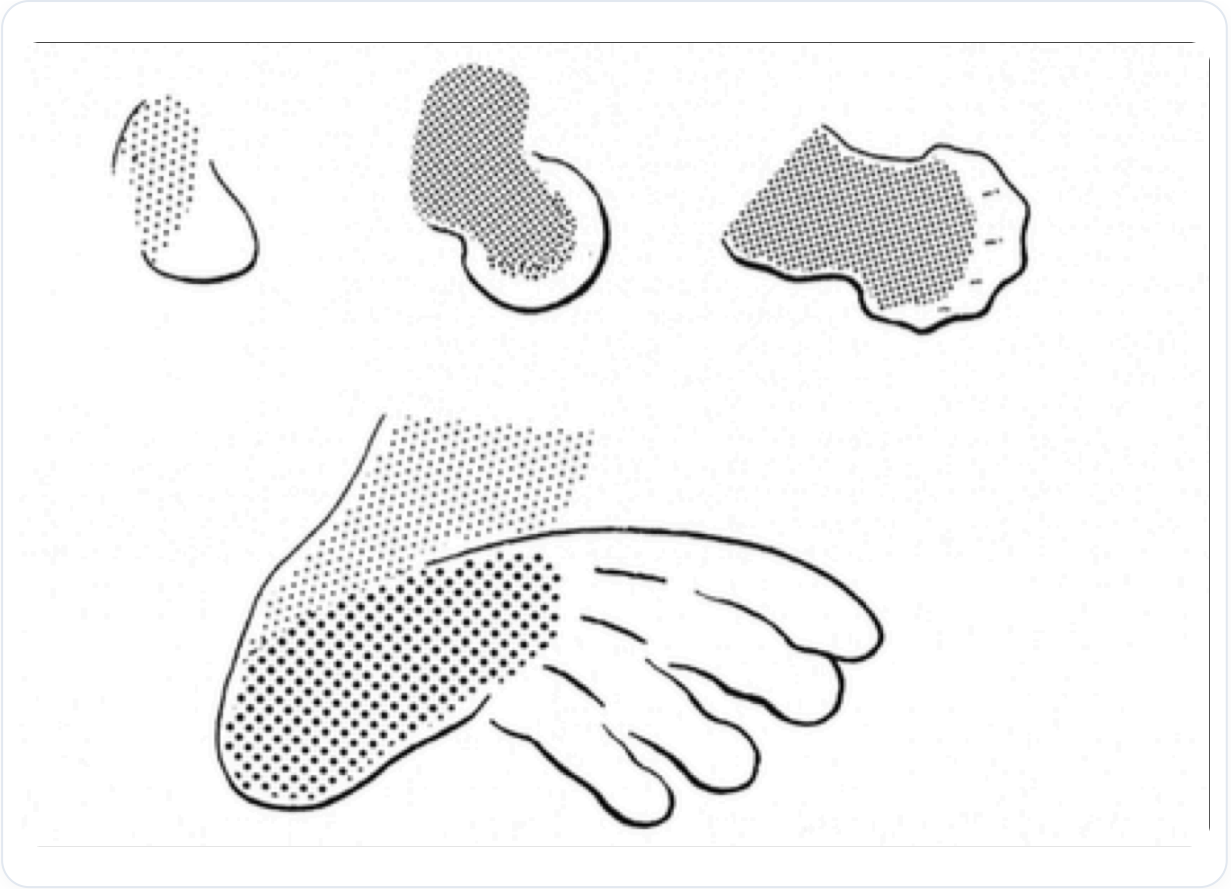


FIG. — Développement membre embryonnaire

Le **mésoblaste** est responsable de l'induction des membres, qui sont une expansion du **sac cardio-pleuro-péritoneal**. Le traitement des lésions des membres nécessite leur rééquilibration avec le **pleuro-péricardio-péritoneal**. En libérant les membres, on permet une meilleure émergence des structures supérieures et inférieures.

L'axe vasculaire est fondamental pour comprendre la métamérisation et la disposition des membres.

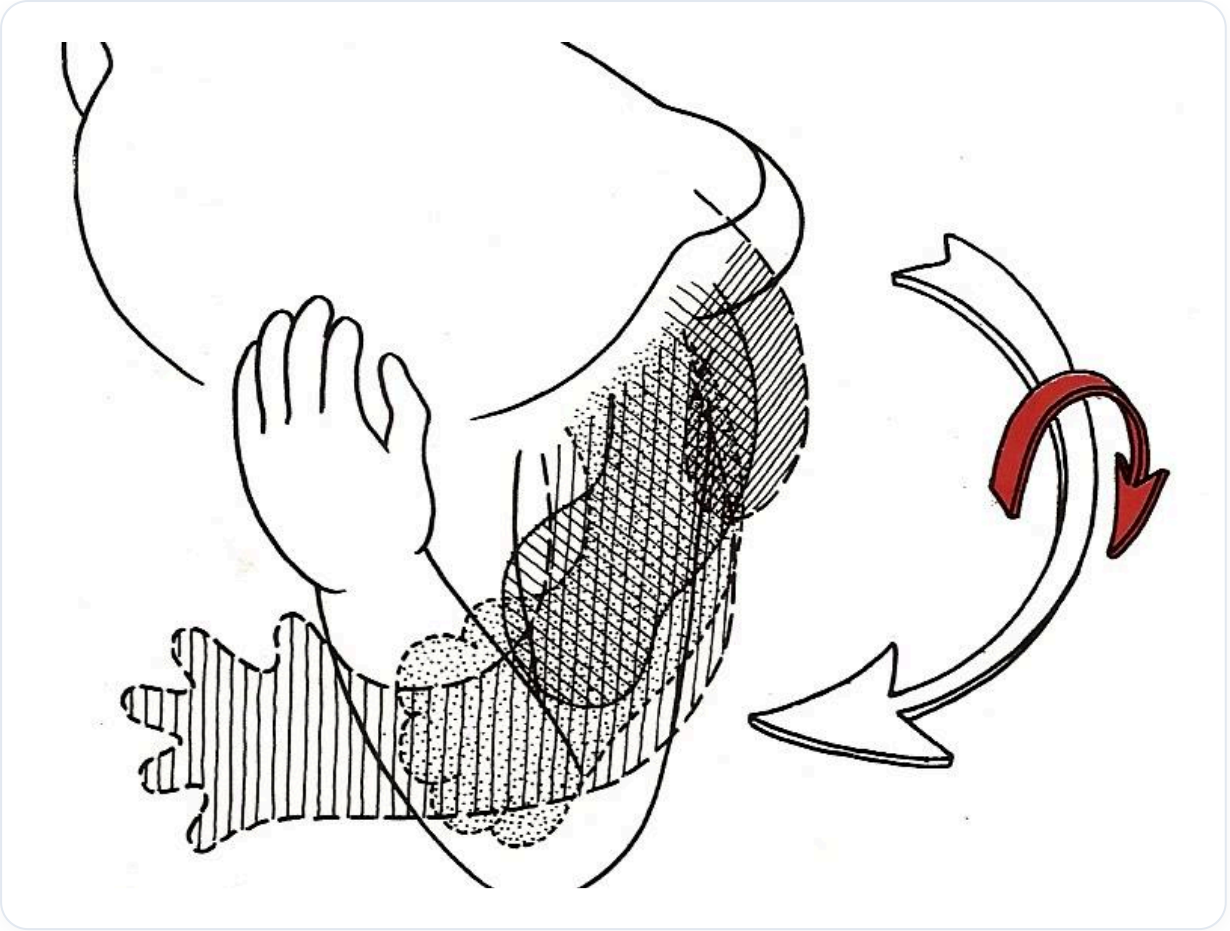


FIG. — Rotation membre supérieur

Chaque métamère est organisé par les vaisseaux et la crête neurale, et chaque vertèbre correspond à un organe. Les dermalgies vertébrales sont liées à des organes spécifiques, comme le foie ou la vésicule biliaire.

L'induction du cellulome est orientée par le champ vasculaire, influençant la croissance des membres. La dynamique entre l'os et le muscle est essentielle : au début, l'os est actif, tandis que le muscle est passif. Avec le temps, le muscle prend le relais, définissant la forme des membres.

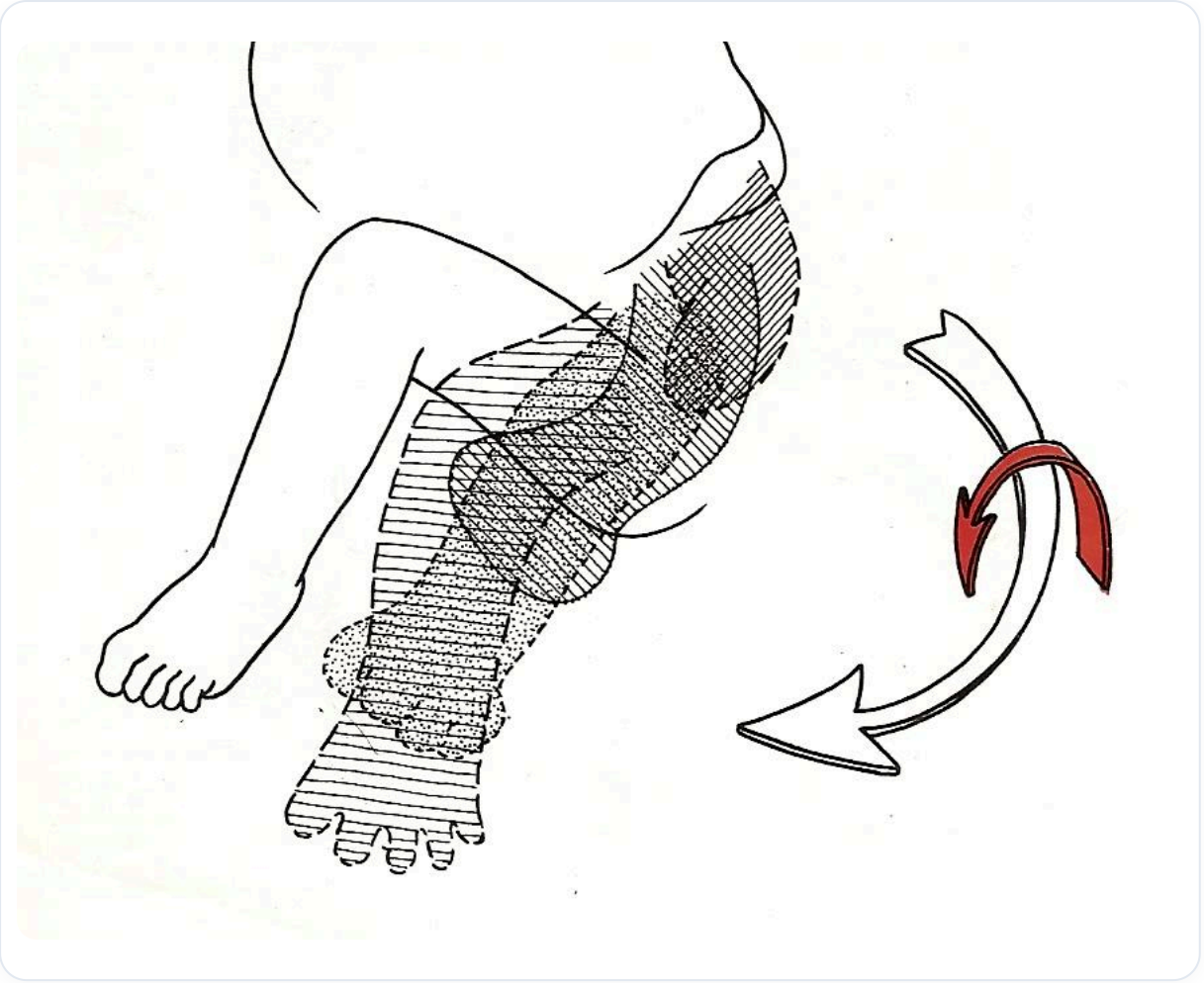


FIG. — Rotation membre inférieur

Le développement des membres, tant supérieurs qu'inférieurs, est lié à la **contre-rotation** et à l'organisation du péritone. La base du crâne et la colonne vertébrale dérivent du **mésenchyme para-axial**, tandis que le squelette des membres provient de la **somatopleur**.

Traiter les lésions des membres implique de les réintégrer dans leur cavité péritonelle, ce qui est une clé pour comprendre le fulcrum embryonnaire.

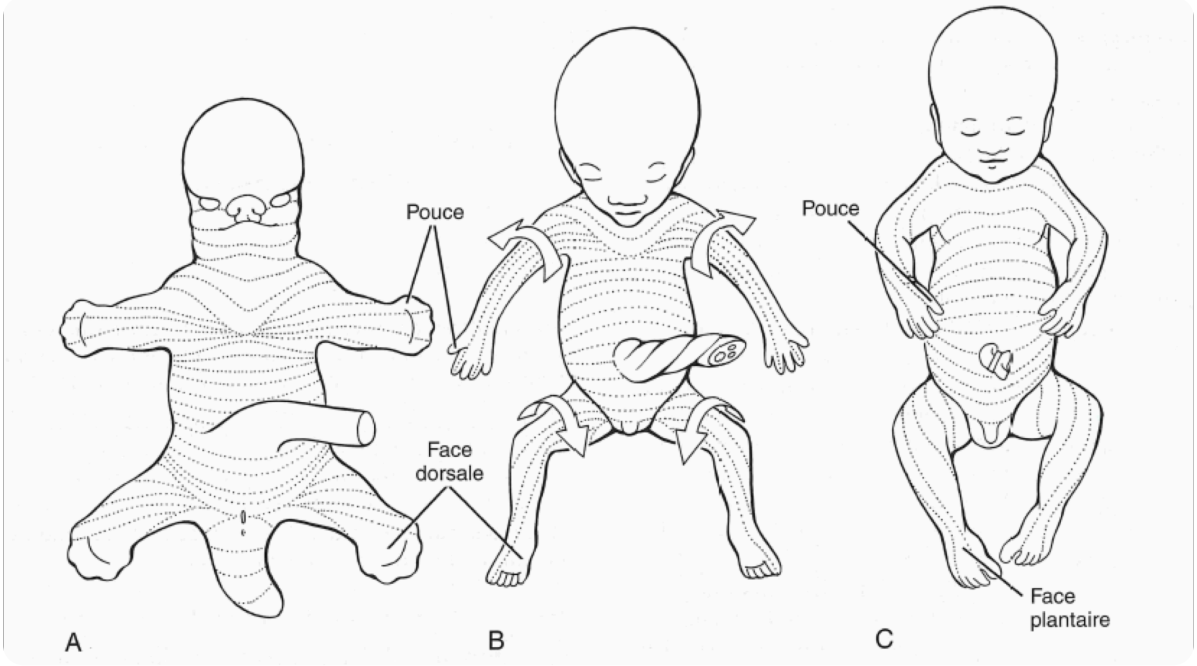


FIG. — Lignes de Langer embryonnaires